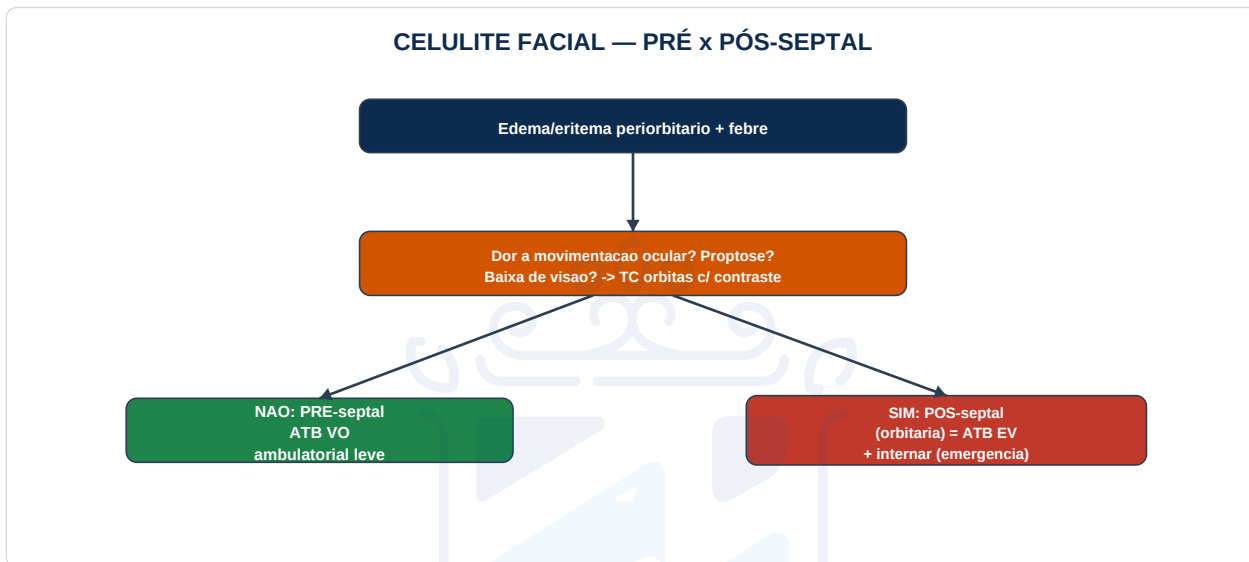


CELULITE DE FACE — PRÉ x PÓS-SEPTAL

FLUXOGRAMA — A DISTINÇÃO QUE SALVA O OLHO



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Infecção bacteriana dos tecidos moles periorbitários/orbitários
- PRÉ-SEPTAL: limitada aos tecidos ANTERIORES ao septo orbitário (mais benigna)
- PÓS-SEPTAL (orbitária): POSTERIOR ao septo — risco de complicações oftalmológicas e intracranianas
- A distinção é fundamental: a pós-septal é EMERGÊNCIA infecciosa
- Etiologia: sinusite (sobretudo etmoidal), trauma/picada, infecção odontogênica, conjuntivite. Agentes: *S. aureus*, *S. pyogenes*, *S. pneumoniae*, *H. influenzae* (não vacinados)

DIFERENCIAÇÃO CLÍNICA — PRÉ x PÓS-SEPTAL

Característica	Pré-septal	Pós-septal (orbitária)
Dor ocular	Ausente ou leve	Presente e intensa
Movimentação ocular	Preservada	Dor e limitação (oftalmoplegia)
Proptose	Não	Sim
Acuidade visual	Normal	Pode estar reduzida
Sinais sistêmicos / risco SNC	Leves / baixo	Febre alta, toxemia / alto

RED FLAGS — CELULITE ORBITÁRIA

EMERGÊNCIA INFECCIOSA

- Dor à movimentação ocular, oftalmoplegia, proptose, queda de acuidade visual
- Cefaleia intensa, vômitos, rebaixamento, sinais meníngeos -> extensão intracraniana
- Suspeita de trombose de seio cavernoso ou abscesso (subperiosteal/cerebral)
- TC de crânio e órbitas COM CONTRASTE é o exame-chave
- Punção lombar NÃO é rotina — considerar (após TC) se sinais meníngeos/RNC/convulsão/extensão intracraniana, com infecto/neuro

AVALIAÇÃO E EXAMES

NO PS

- Checklist: febre/toxemia, dor e mobilidade ocular, proptose e acuidade visual, sinais neurológicos, sinusite recente
- Hemograma, PCR; hemoculturas antes do antibiótico (se possível)
- TC de crânio e órbitas com contraste (exame-chave): pré-septal = edema anterior ao septo;
- pós-septal = infiltração da gordura orbital, proptose, possível abscesso subperiosteal
- Avaliação oftalmológica (acuidade visual seriada na orbitária)

TRATAMENTO

Rx PRÉ-SEPTAL (sem gravidade)

Amoxicilina + Clavulanato 875/125mg VO 12/12h por 7-10 dias
Alergia: Cefalexina 500mg VO 6/6h OU Clindamicina 300mg VO 6-8/8h
Reavaliação em 48h; internar se toxemia, imunossupressão ou falha
Vigiar surgimento de sinais pós-septais (dor à mov. ocular, proptose)

Rx PÓS-SEPTAL (orbitária) — EV + internar

Ceftriaxona 2g EV 1x/dia + Oxacilina 2g EV 4-6/6h
Suspeita de MRSA: Vancomicina 15-20 mg/kg EV 8-12/12h
Sinusite grave/abscesso: adicionar Metronidazol 500mg EV 8/8h (anaeróbios)
EV por 10-14 dias, transição para VO após melhora sustentada
Avaliação ORL + oftalmologia

INDICAÇÃO CIRÚRGICA E INTERNAÇÃO

DRENAGEM / INTERNAR

- Cirurgia (drenagem) se: abscesso subperiosteal/orbital, perda visual progressiva, sem melhora em 48-72h de ATB EV, complicação intracraniana
- INTERNAR: TODOS os casos pós-septais
- INTERNAR: pré-septal com toxemia, imunossuprimidos, falha ambulatorial
- Alta (pré-septal): afebril 24-48h, redução do edema/dor, sem sinais oculares/neurológicos, plano ATB VO definido

CHECKLIST

NÃO ESQUECER

- ☐ Diferenciar pré x pós-septal (dor à mov. ocular, proptose, acuidade visual)
- ☐ TC de órbitas com contraste se qualquer sinal pós-septal
- ☐ Pós-septal = ATB EV + internação + ORL/oftalmo imediatos
- ☐ Buscar e tratar a sinusite/foco causal
- ☐ Acuidade visual seriada na celulite orbitária

MODELO DE ENCAMINHAMENTO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Celulite () pré-septal () pós-septal (orbitária). Febre ____; dor ocular: sim/não; proptose: sim/não.
- TC de órbitas: ____ (gordura orbital/abscesso subperiosteal). Acuidade visual: ____.
- ATB EV iniciado: ____; avaliação oftalmológica: sim/não.
- Motivo da transferência: celulite orbitária / abscesso / avaliação cirúrgica.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com edema periorbitário, dor intensa à movimentação ocular, proptose e queda de acuidade visual, febril. Diagnóstico e conduta?

- A) Celulite pré-septal — antibiótico oral ambulatorial
- B) Celulite pós-septal (orbitária) — emergência: TC de órbitas, antibiótico EV e internação
- C) Conjuntivite alérgica — colírio anti-histamínico
- D) Hordéolo — compressas quentes
- E) Blefarite — higiene palpebral

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o exame-chave para diferenciar celulite pré-septal de pós-septal?

- A) Radiografia de face
- B) Tomografia de crânio e órbitas com contraste
- C) Ultrassonografia ocular
- D) Hemograma
- E) Fundoscopia isolada

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é a principal causa de celulite orbitária?

- A) Conjuntivite viral
- B) Sinusite bacteriana (especialmente etmoidal)
- C) Catarata
- D) Glaucoma
- E) Pterígio

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual achado clínico está presente na celulite pós-septal, mas NÃO na pré-septal?

- A) Edema palpebral
- B) Proptose com dor/limitação à movimentação ocular
- C) Eritema cutâneo
- D) Febre baixa
- E) Lacrimejamento

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quando indicar drenagem cirúrgica na celulite orbitária?

- A) Sempre, antes do antibiótico
- B) Abscesso subperiosteal/orbital, perda visual progressiva ou ausência de melhora após 48-72h de ATB EV
- C) Apenas em crianças
- D) Nunca
- E) Somente se houver febre

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor à movimentação ocular + proptose + queda de acuidade visual define celulite pós-septal (orbitária) — emergência infecciosa: TC de órbitas com contraste, antibiótico EV e internação imediata, com ORL/ofタルモ.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A TC de crânio e órbitas com contraste é o exame-chave: a pré-septal mostra edema anterior ao septo; a pós-septal mostra infiltração da gordura orbital, proptose e eventual abscesso subperiosteal.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A sinusite bacteriana, sobretudo etmoidal, é a principal causa de celulite orbitária pela proximidade anatômica e disseminação através da lâmina papirácea.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Proptose com dor/limitação à movimentação ocular (e possível baixa de visão) caracteriza o acometimento pós-septal; a pré-septal mantém movimentação preservada, sem proptose e com visão normal.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Indica-se drenagem cirúrgica na celulite orbitária diante de abscesso subperiosteal/orbital, perda visual progressiva, falha após 48-72h de ATB EV ou complicações intracranianas.

SM24
Suporte ao Plantão Médico